

Fecha Última Actualización: 22-02-2023 15:25:45

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Berta Inés Araneda Vilches
Edad : 62a 6m 20d
Dirección : Pje Calisto 1551

Rut : 9.755.559-1
Fecha Nacto: 02/08/1960
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1936753
Sexo : Femenino
Teléfono : 949613330

N° Epicrisis
342194

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 30/01/2023 10:07
Fecha Egreso : 22/02/2023 15:02

Días Estadía: 23

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cirrosis Hepatica - THO

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR : 30/01/23
FI UCI : 31/01/23 (00:15 hr)
F I I Qx : 07/02 /23

ANTECEDENTES:

- Antec. Mórbitos: DHC por HAI hace 3 años, Child C (11 puntos) MeldNa 31, anemia en estudio, HTA, bocio multinodular
- o Complicaciones DHC: Ascitis (+); PBE (-), SHR (-), EH (-), HDA (-), Coagulopatía (+), HCC (-).
- o Ecocardiograma del 12/22: FEVI 72%, buena FSGS. AI severamente dilatada con volumen de 86 ml. Reflujo aórtico y mitral ligero. VD con función normal. TAPSE 29 mm. PSAP de 39 mmHg. Sin shunt en prueba de SF agitado.
- o EDA 9/1/23: Varices esofágicas grandes sin signos de riesgo. Gastropatía erosiva y atrófica antral.
- Antec. Qx: Tu renal izq operado, colecistectomía
- Alergias: (-)
- Meds: Espironolactona 100mg/día, Furosemida 40mg/día, Omeprazol 20 mg/día, Prednisona 5 mg/día, Lactulosa SOS
- Adherencia a tratamiento: Buena adherencia a tratamiento, niega olvidos
- Hábitos: Tabaco (-)/Drogas(-)/OH (-)
- Social: Auxiliar de aseo en clínica
- Antec. familiares: Hermano DM/HTA
- Hospitalizaciones recientes: Diciembre/2022 por DHC descompensado con Ascitis (se descarta HCC, trombosis portal y PBE)
- Inmunizaciones: COVID 4 dosis

HISTORIA CLÍNICA:

Paciente ingresa el 30/01 de forma electiva para THO de donante cadavérico. Derivada por DHC por HAI en corticoterapia hace más de 3 años. Meld-Na 31 (con exámenes del 9/01/23) y Child C. Única descompensación de DHC en diciembre 2022 en contexto de ascitis refractaria, sin PBE.

Ingresa a pabellón a las 17:00 hr. Tiempo total de cirugía 4:40 hr, TIF 4:50 hr TIC 28 min, HOPE 3:18 hr, isquemia arterial 30 min. Egresos sangrados 3.700 y diuresis 420 cc. Ingresos 6 U GR + 8 PFC + 3 pool Crio + 1.500 cc albúmina + 500 cc de

Fecha Epicrisis : 22/02/2023 15:25

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 22-02-2023 15:25:45

Página 2 de 3

cristaloides. BH total 2.180. Con requerimientos de NAD hasta 0.5 ug/kg/min en fase de reperfusión. Inducción con Metilprednisolona 1 gr + Baciliximab 20 mg.

EXAMEN FÍSICO

EEII: Edema bilateral leve. Sin signos de TVP.

Ecoscopia cardíaca: Contractibilidad de VI conservada VTI 39. Sin signos de sobrecarga derecha.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A I Qx:

- Daño Hepático Crónico por HAI. MeldNa 33 / Child-C.
- THO donante cadavérico 30/01
- o TIF: 4:50 Hrs
- o TIC: 28 min
- o HOPE: 3:18 Hrs
- o Isquemia arterial: 30 min.
- o Qx Total 4:40 Hrs
- Antecedentes

Paciente cursó con rechazo agudo de órgano por lo que fue llevada a pabellón nuevamente el 02/02 en su tercer día PO. Se realiza hepatectomía total de hígado trasplantado y se realiza nuevo trasplante hepático con otro órgano.

Desde entonces progresivamente mejor hasta hoy en que se decide su traslado a Intermedio quirúrgico. Paciente evoluciona con falla renal aguda que requirió apoyo dialítico con buena respuesta actualmente recuperada, Durante hospitalización se logran niveles de tacrolimus deseado

Actualmente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia estable con buena tolerancia oral, por lo que se decide alta para continuar manejo y seguimiento ambulatorio

Diagnóstico de Egreso

OTRAS CIRROSIS DEL HÍGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS - THO + RETrasplante

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia estable, con debilidad muscular con requerimiento de kinesioterapia.

Plan Post Alta

- Continuar manejo y seguimiento ambulatorio por hepatología y cirugía hepatobiliar
- Alta con HD para kinesioterapia y evaluación de control glicémico
- Indicaciones:

1- Fármacos según indicación de hepatología:

Aciclovir 200mg cada 12 hrs
Aspirina 100 mg cada 24 hrs
cotrimoxazol forte 1 comp cada 24 hrs Lunes -Miércoles-Viernes
Micofenolato mofetil 750 mg cada 12 hrs
Omeprazol 20 mg cada 24 hrs
Prednisona 15mg cada 24 hrs
Tacrolimus 2mg AM-3mg PM
Paracetamol 1 gr cada 8 hrs
Magnatil 1 comprimido día
Elcald -D 1 comp al día

2- Medir glicemia 06-12-18

- Ajustar insulina NPH 18 unidades AM y 6 unidades PM vía subcutánea
- Insulina cristalina según esquema diferenciada:
DESAYUNO-ALMUERZO (HGT 6-12 hrs)
Menos de 100: nada

Fecha Epicrisis : 22/02/2023 15:25

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 22-02-2023 15:25:45

100-140: 4
141-180: 6
181-220: 8
221-260: 10
261-300: 12
Más de 300: 14

CENA (HGT 18 hrs)
menor a 160: nada
160-200: 4
201-240: 8
241-280: 10
más de 280: 12

- Ajustar horario de prednisona a las 7 AM para favorecer control glicémico
- Seguimiento por equipo, reevaluación 22/02

Indicaciones

Tipo de Reposo : -

Régimen Alimentario : -

Medicamentos :

Controles



Jose Esteban Ruiz Cabrera

INTERNO

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)